

Información Paciente

Nombre : Mireya De Las Mercedes Olmedo Saave **Rut** : 5.890.212-8 **N° Archivo** : 2303402
Edad : 76a 4m 14d **Fecha Nacto**: 09/11/1946 **Sexo** : Femenino
Dirección : Los Jesuitas 3091 **Comuna** : Puente Alto **Teléfono** : 9 9419 8711

N° Epicrisis
346860

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Pre-Alta Adulto **Fecha Ingreso** : 18/02/2023 14:18 **Días Estadía**: 33
Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto **Fecha Egreso** : 23/03/2023 17:03

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

dolor abdominal

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

ANTECEDENTES

- ¿ -Mórbidos: HTA, hipotiroidismo, Dislipidemia, Fibromialgia
- ¿ -Fármacos: Atorvastatina, Valsartán, Eutirox
- ¿ -Quirúrgicos: colecistectomía, histerectomía
- ¿ -Inmunizaciones: COVID-19 4 dosis, Neumococo al día, influenza no al día (última 2020)

HISTORIA DE INGRESO:

Paciente con antecedentes descritos ingresa a urgencias por cuadro de 6 horas de evolución de dolor abdominal difuso de carácter cólico asociado a ausencia de deposiciones y tránsito a gases, náuseas, sin vómitos, intensidad hasta EVA 8/10, sin respuesta a analgesia, vigil, con abdomen blando, depresible, abdomen doloroso a la palpación difusa, Blumberg (+), TAC AP tomado: obstrucción mecánica de alto grado de asas de intestino delgado, con cambio calibre abrupto, probablemente determinado por bridas. Probables fenómenos isquémicos en íleon distal al punto de transición. Leve ascitis difusa y acentuado edema y líquido libre en las hojas del mesenterio.

Evaluada inicialmente por Cirugía, sin indicación quirúrgica, evoluciona con hipotensión arterial y deterioro clínico, ingresa a pabellón el 19/02: laparotomía exploradora + aseo quirúrgico + resección intestinal de segmento de intestino delgado de 15 a 90 cm del Treitz + cierre y abandono cabos + instalación Bolsa de Bogotá.

Evoluciona en postoperatorio inmediato con shock séptico que logra estabilizarse para posteriormente ingresar por segunda vez a pabellón para cierre de cavidad ya anastomosis intestinal.

Ingresa a UCI con diagnóstico de

Diagnósticos:

- Shock séptico foco abdominal.
- o Obstrucción intestinal por bridas
- § Laparotomía exploradora 19/12
- Aseo quirúrgico, resección de intestino delgado (15 cma a 90 cm del Treitz), cabos abandonados, laparostomía.
- § Laparotomía exploradora 22/12
- Aseo quirúrgico, resección de intestino delgado (75 cm), anatomosis de delgado, cierre de cavidad.
- o Fallo orgánico múltiple
- § Falla hemodinámica refractaria

Fecha Epicrisis : 23/03/2023 17:23

Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



Fecha Última Actualización: 23-03-2023 17:23:35

Página 2 de 2

§ Falla respiratoria severa
§ Falla renal KDIGO 2
§ Coagulopatía

Intercurre durante su estadía en UCI con:

- Colección peri esofágica asociada a perforación esofágica distal
- FA de alta respuesta ventricular
- Neumonía por KPN + SAMS
- o Imipenem FI 26/2/23
- Peritonitis por Klebsiella oxytoca
- o Imipenem FI 26/2/23
- Derrame pleural bilateral mayor a derecho
- o Pleurostomía
- TVP yugular interna derecha
- TVP yugular interna izquierda
- Sepsis - foco en estudio - 17/03/2023
- o se agrega VANCO y ANIDULA al esquema

Nuevo evento inflamatorio de foco mediastinal que no se puede controlar quirúrgicamente; evoluciona con deterioro hemodinámico y respiratorio, ante imposibilidad de control de foco quirúrgico se establece proporcionalidad del tratamiento, fallece el 23/03/2023 junto con sus allegados.

Diagnóstico de Egreso

Shock séptico -

Condición de Egreso Fallecido

se realiza certificado de defunción

Egreso con Catéter Doble J:NO

Plan Post Alta

Indicaciones

Tipo de Reposo :

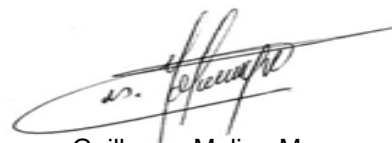
Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente



Guillermo Molina Mancero
Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 23/03/2023 17:23

Página 2 de 2

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 17:58

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar